UE B1 · Sciences biomédicales

Hémostase : former puis résorber le caillot

La séquence en trois temps

1 · Hémostase primaire : vasoconstriction, adhésion puis agrégation des plaquettes.

2 · Coagulation : thrombine → fibrinogène transformé en fibrine → caillot stabilisé.

3 · Fibrinolyse : dégradation progressive du caillot, notamment par la plasmine.

Bilans et facteurs à reconnaître

TP : explore surtout les voies extrinsèque et commune ; TCA : surtout la voie intrinsèque.

Facteurs vitamine K dépendants : II, VII, IX, X.

Surveillance IDE : relier biologie et clinique

Rechercher saignements, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, hématurie, méléna.

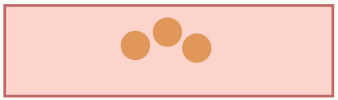
Connaître les anticoagulants et antiagrégants prescrits ; vérifier les bilans demandés.

Transmettre une anomalie ou un signe de gravité sans attendre le seul résultat biologique.

Hémostase : le caillot en 3 temps

La séquence à retenir · les étapes se chevauchent dans l·organisme.

1 · HÉMOSTASE PRIMAIRE



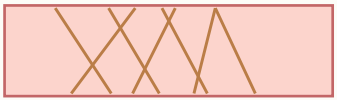
Vasoconstriction

Plaquettes adhèrent

puis s·agrègent

Clou plaquettaire

2 · COAGULATION



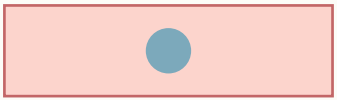
Thrombine active

Fibrinogène · fibrine

Réseau fibrineux

Caillot stabilisé

3 · FIBRINOLYSE



Plasmine active

Fibrine dégradée

Caillot résorbé

Retour progressif

Repère de sécurité

TP/INR et TCA : relier au traitement, au labo et au contexte.

Observer les saignements ; transmettre les signes préoccupants.

Source : Manuel MSD, Comment le sang coagule-t-il ? · consulté le 16/10/2026